Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Endolarengeal Mikrocerrahi

Ses telleri / gırtlak mikrocerrahisi (mikrolarengoskopi)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Lezyon / ön tanı: _____

Taraf: ☐ Sağ ses teli ☐ Sol ses teli ☐ İki taraflı ☐ Diğer gırtlak bölgesi _____

Planlanan teknik: ☐ Soğuk alet ☐ CO2 lazer ☐ Hekim tarafından ameliyatta belirlenecek

Biyopsi / patolojik inceleme: ☐ Planlanıyor ☐ Gerek görülürse ☐ Planlanmıyor _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Gırtlak (larenks), boynun ön tarafında yer alan; sesi oluşturan, nefes yolunu koruyan ve yutma sırasında soluk borusunu kapatan bir organdır. Ses telleri gırtlağın içinde bulunan, titreşerek sesi oluşturan iki ince yapıdır.

Ses tellerinde veya gırtlağın başka bir bölümünde **nodül, polip, kist, Reinke ödemi, papillom, lökoplaki (beyaz plak)** gibi oluşumlar ya da kanser şüphesi taşıyan bir lezyon olabilir. Bu oluşumlar ses kısıklığı, seste yorulma, boğazda takılma hissi ve nadiren nefes darlığına neden olabilir. Nedenleri arasında sesin yanlış veya aşırı kullanımı, sigara, reflü, enfeksiyonlar (ör. HPV) ve bazen bilinmeyen etkenler sayılabilir.

Ameliyatın amacı lezyonu ses tellerinin sağlıklı dokusunu mümkün olduğunca koruyarak çıkarmak, **sesinizi iyileştirmek**, gerekiyorsa nefes yolunu genişletmek ve çıkarılan dokunun **patolojik incelemesiyle kesin tanıyı** koymaktır.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında ağız yoluyla yapılır; boyunda kesi yapılmaz.

1. **Gırtlağa ulaşma:** Uyuduktan sonra ağzınızdan metal bir tüp (laringoskop) yerleştirilerek gırtlağa ulaşılır. Dişleriniz özel bir koruyucu ile korunur.
2. **Mikroskop ile inceleme:** Ses telleri ameliyat mikroskobu veya endoskop ile büyütülerek ayrıntılı incelenir. Muayenede görülmeyen ek bulgular burada ortaya çıkabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3. **Lezyonun çıkarılması:** Lezyon, çok ince mikrocerrahi aletleri veya CO2 lazer ile, ses telinin titreşen yüzeyi mümkün olduğunca korunarak çıkarılır. Gerekirse yalnızca tanı amacıyla küçük bir parça (biyopsi) alınır.
4. **Ek uygulamalar:** Duruma göre kanamayı durdurmak için ilaçlı pamuklar, iz oluşumunu azaltmak için ses teline ilaç enjeksiyonu yapılabilir.
5. **Bitiş:** Laringoskop çıkarılır, ağız ve dişler kontrol edilir. Boyunda dikiş veya dışarıdan görünen bir iz olmaz.

Çok nadiren, ağız açıklığı, dişlerin yapısı, çene veya boyun anatomisi nedeniyle gırtlağa güvenli şekilde ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda işlem durdurulabilir ve size alternatif yöntemler anlatılır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 20–60 dakika	Genellikle aynı gün veya 1 gece hastanede kalış

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Ses kısıklığının azalması ve sesin daha net, daha az yorulan hâle gelmesi
- Çıkarılan dokunun patolojik incelemesiyle **kesin tanının** konulması; erken dönemde saptanan bir hastalığın zamanında tedavi edilebilmesi
- Lezyon nefes yolunu daraltıyorsa nefes almanın rahatlaması

Nodül, polip ve kist gibi iyi huylu lezyonlarda hastaların büyük çoğunluğunda ses belirgin şekilde düzelir. Ancak sonuç; lezyonun türüne, büyüklüğüne, ses tellerinin önceki durumuna, sigara ve reflü gibi etkenlere ve ameliyat sonrası **ses istirahati ile ses terapisine** uyuma bağlıdır. Papillom gibi bazı hastalıklar tekrarlayabilir ve birden fazla ameliyat gerektirebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ses terapisi (konuşma terapisti eşliğinde):** Özellikle ses teli nodüllerinde ilk seçenek olabilir ve çoğu zaman ameliyata gerek bırakmaz.
- **İlaç tedavisi:** Reflü veya iltihaba bağlı durumlarda mide asidini azaltan ve iltihabı gideren ilaçlar fayda sağlayabilir.
- **Sigarayı bırakma ve ses hijyeni:** Bazı lezyonlarda (ör. Reinke ödemi) gerilemeye katkı sağlar.
- **Lokal anestezi ile ofiste işlem:** Uygun seçilmiş küçük lezyonlarda veya biyopside, burundan veya ağızdan endoskopla uyanıkken işlem yapılabilir; her lezyon için uygun değildir.
- **Yakın takip:** Kanser şüphesi taşımayan küçük lezyonlarda belirli aralıklarla muayene ile izlenebilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa ses kısıklığınız devam edebilir veya artabilir. Lezyonun türü kesin olarak bilinmediği için, nadir de olsa altta yatan ciddi bir hastalığın (ör. erken evre kanser veya kansere dönüşebilen lezyon) tanısı gecikebilir. Büyüyen lezyonlar nadiren nefes darlığına yol açabilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri yapılır, anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- **Sallanan dişlerinizi, kronlarınızı, köprülerinizi, implantlarınızı ve takma dişlerinizi** mutlaka bildiriniz; takma dişler ameliyattan önce çıkarılır.
- Reflü tedavisi önerildiyse ameliyattan önce başlamanız istenebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24–48 saat	Boğazda ağrı veya yanma, yutkunurken hafif rahatsızlık, ses kısıklığı ve az miktarda kanlı balgam olabilir. Dilinizde uyuşukluk, tat değişikliği veya çenede ağrı hissedebilirsiniz; bunlar genellikle birkaç gün içinde geçer.
1. hafta	Hekiminizin önerisine göre genellikle **3–7 gün tam ses istirahati** (hiç konuşmamak, fısıldamamak) ve ardından kademeli ses kullanımı önerilir. Masa başı işe genellikle 2–3 gün içinde dönülebilir; sesle çalışanlar (öğretmen, şarkıcı, çağrı merkezi) daha uzun süre beklemelidir.
2–4. haftalar	Ses yavaş yavaş düzelir. Gerekirse ses terapisi başlanır. Bağırmak, şarkı söylemek ve uzun süreli konuşmaktan kaçınılır. Patoloji sonucu genellikle bu dönemde çıkar ve sizinle paylaşılır.
1–3. aylar	Ses tellerinin iyileşmesi tamamlanır; sesin son hâli genellikle **6–12 hafta** içinde ortaya çıkar. Kontrol muayenesinde ses telleri endoskopla değerlendirilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Boğaz ağrısı ve yutkunurken hafif rahatsızlık (birkaç gün)
- Ameliyat sonrası geçici ses kısıklığı veya ses tonunda değişiklik
- Az miktarda kanlı balgam (ilk 1–2 gün)
- Çene, dudak veya dişlerde hassasiyet; ağız köşelerinde küçük çatlaklar

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Dilde uyuşukluk ve tat değişikliği** — Laringoskopun dile yaptığı basınca bağlıdır; yaklaşık 100 hastadan **5–15'inde** görülür, genellikle birkaç gün–birkaç hafta içinde düzelir, çok nadiren aylarca sürebilir.
- **Çene eklemi ağrısı** — Ağzın uzun süre açık tutulmasına bağlıdır; genellikle birkaç günde geçer. Önceden çene eklemi sorunu olanlarda daha sık ve uzun sürebilir.
- **Sesin beklenen kadar düzelmemesi** — Ses ameliyattan sonra her zaman tam olarak normale dönmeyebilir; ses terapisi veya ek tedavi gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Seyrek görülen durumlar

- **Diş hasarı** — Koruyucu kullanılmasına rağmen yaklaşık 100 hastadan **1–5'inde** dişte kırılma, çatlama, sallanma veya kron/köprü hasarı olabilir. Önceden sallanan, çürük veya protez dişlerde risk daha yüksektir; diş tedavisi gerekebilir.
- **Sesin kötüleşmesi veya kalıcı ses değişikliği** — Ses teli yüzeyinde iz dokusu (skar) oluşursa ses ameliyattan öncekinden daha kısık, daha zayıf veya daha çabuk yorulan hâle gelebilir. Bu durum ses terapisi ve bazen ek ameliyatlar gerektirebilir; nadiren kalıcı olabilir.
- **Lezyonun tekrarlaması** — Özellikle ses kötüye kullanılmaya devam edilirse, sigara içilirse veya papillom gibi hastalıklarda lezyon yeniden oluşabilir ve tekrar ameliyat gerekebilir.
- **Ön bölgede yapışıklık (web)** — Her iki ses telinde ön bölgeye yakın işlem yapıldığında ses telleri birbirine yapışabilir; ses kalitesini bozabilir ve ikinci bir ameliyatla ayrılması gerekebilir.
- **Patoloji sonucuna göre ek tedavi** — Patoloji sonucu öngörülenden farklı çıkabilir (ör. kansere dönüşme eğilimi olan lezyon veya kanser). Bu durumda ek ameliyat, ışın tedavisi veya yakın takip gerekebilir; bu durum size ayrıntılı olarak anlatılır.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Gırtlakta şişlik (ödem) ve nefes darlığı** — Ameliyattan sonra gırtlakta şişlik gelişebilir. Genellikle ilaçla düzelir; çok nadiren gözlem için yoğun bakımda kalmak veya geçici olarak boyundan nefes yolu açılması (trakeotomi) gerekebilir.
- **Kanama** — Belirgin kanama nadirdir. Kanın nefes yoluna kaçması riski nedeniyle ciddi kanama hızlı müdahale ve yeniden ameliyathaneye alınmayı gerektirebilir.
- **Lazer ile ilgili riskler** — CO2 lazer kullanıldığında çevre dokuda yanık ve çok nadiren nefes tüpünün tutuşması (hava yolu yangını) riski vardır. Lazere özgü güvenlik önlemleri (özel tüp, ıslak pamuklar, göz koruması) uygulanır. Böyle bir olay gerçekleşirse nefes yolunda ciddi yanık, uzun süreli yoğun bakım tedavisi ve trakeotomi gerekebilir.
- **Ağız, dil, dudak veya yutak yaralanması** — Aletlere bağlı küçük yaralanmalar genellikle kendiliğinden iyileşir; çok nadiren dikiş gerekebilir. Son derece nadiren yutak duvarında yırtılma olursa boyunda cilt altına hava kaçması (ciltte çıtırtı) veya boyun enfeksiyonu gelişebilir; hastanede gözlem, damar yoluyla antibiyotik ve nadiren ameliyat gerekebilir.
- **Boyun omurlarına bağlı sorunlar** — Başın arkaya doğru konumlandırılmasına bağlı olarak, özellikle boyun omurlarında hastalığı olanlarda boyun ağrısı ve çok nadiren daha ciddi omurga sorunları görülebilir. Boyun fıtığı veya boyun ameliyatı öykünüzü bildiriniz.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Nefes darlığı**, nefes alırken ıslık veya hırıltı sesi (stridor)
- **Kan tükürme veya kan kusma**, kanlı balgamın azalmak yerine artması
- **Yutamama**, ağzınızdaki tükürüğü yutamayacak kadar ağrı veya şişlik
- **38,5 °C üzerinde ateş** ve giderek artan boğaz ağrısı
- Boyunda veya yüzde şişlik ya da ciltte çıtırtı hissi

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Önerilen **ses istirahatine** kesinlikle uyunuz; fısıldamak da ses tellerini yorar. İhtiyaçlarınızı yazarak veya telefon uygulamalarıyla iletebilirsiniz.
- Bol su içiniz; ortam havasını nemli tutunuz. Boğaz temizleme ve öksürmeden mümkün olduğunca kaçınınız.
- Sigara ve sigara dumanından uzak durunuz; sigara hem iyileşmeyi bozar hem de lezyonun tekrarlama riskini artırır.
- Reflü ilacı verildiyse önerilen süre boyunca kullanınız; yatmadan önceki 2–3 saat içinde yemek yemeyiniz, baharatlı ve asitli yiyecekleri sınırlayınız.
- Uçak yolculuğu genellikle ertesi gün güvenlidir; yolculuk sırasında ses istirahatine devam ediniz.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Ameliyat sırasında gırtlağa ulaşmanın güvenli olmadığı anlaşılırsa işlemin durdurulabileceğini; çıkarılan dokunun patoloji sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebileceğini anladım.
- ☐ Sesin son hâlinin ameliyat sonrası ses istirahati, ses terapisi, sigarayı bırakma ve reflü tedavisine uymama da bağlı olduğunu biliyorum.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.